

Fecha Última Actualización: 06-06-2023 17:57:32

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Michel Angelo Castro Munoz

Rut : 19.220.463-1

N° Archivo : 0734478

N° Epicrisis

356691

Edad : 27a 6m 8d

Fecha Nacto: 29/11/1995

Sexo : Masculino

Dirección : Huasco 0239

Comuna : Puente Alto

Teléfono : 9 9090 7172

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Ingreso : 02/05/2023 00:54

Días Estadía: 35

Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Egreso : 06/06/2023 17:06

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FECHA DE INGRESO HSR: 01/05/2023

FECHA DE INGRESO UTIM: 05/05/2023

ANTECEDENTES:

Mórbidos:

- DM1 desde los 13 años secuelado con RDNP severa en panfotocoagulación + avastin, nefropatía, neuropatía y enteropatía.
- ERC en HD desde febrero 2022 en Centro Renal L-M-V por CVC tunelizado subclavio izquierdo. Tiene diuresis residual. Diagnóstico en 2020 con biopsia renal: Glomerulonefritis post infecciosa y nefritis intersticial aguda intensa. En espera de trasplante.
- Anemia secundaria a ERC
- Hipotiroidismo post radioyodo por hipertiroidismo por Basedow-Graves
- Vejiga neurogénica con cateterismo vesical intermitente e ITU recurrente

Quirúrgicos: Absceso perianal (2019), Apendicectomía (2020), Instalación JJ derecho y retiro (nov/2021)

Fármacos: Pregabalina 75 mg/ día v.o, Loperamida 2 mg/ 8 h v.o , Levotiroxina 150 mcg/ día v.o L--V y 200 mcg/ día S y D, Oxibutinina 50 mg/ 12 h v.o, Tresiba 2 U 6 pm SC, Novorapi según esquema, EPO 12 000 U / semana, Hierro 100 mg/ 30 días

Alergias: no

Hábitos: Tbq (+) 7 cig/ día, OH ocasional, cocaína (refiere suspendido)

Hospitalizaciones recientes: Enero 2023 por NAC

Inmunizaciones: COVID 5 dosis, no influenza

MOTIVO DE CONSULTA: Disnea

ANAMNESIS

Paciente con antecedentes descritos, con cuadro de 3 días de evolución de disnea, CEG, congestión nasal, tos productiva. Última diálisis lunes 02/05 completa, posterior a diálisis con mayor disnea por lo que consulta en APS donde se objetiva insuficiencia respiratoria, aportan O2 y derivan a SU CASR. Al interrogatorio dirigido niega fiebre, dolor torácico u otros síntomas asociados.

Al ingreso se describe vigil, hemodinamia estable, sin UMA, satO2 97% con MNR 15 L. Examen físico sin alteraciones. Del

Fecha Epicrisis : 06/06/2023 17:57

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 06-06-2023 17:57:32

Página 2 de 4

laboratorio destacan parámetros inflamatorios elevados (PCR 207, GB 33.650), anemia severa con Hb 5.9, hiponatremia en 131.

COVID19 (-) Panel respiratorio ampliado (-)

Por anemia severa, sin exteriorización de sangrado, se realiza Tx 2U GR.

Se mantiene con apoyo de O2 y se solicita TAC de tórax 02/05 donde destaca derrame pleural bilateral mayor a derecha y atelectasia completa de pulmón.

Se realiza toracocentesis que confirma exudado y se instala drenaje 04/05 que evacúa líquido seropurulento. Paralelamente, presenta diarrea líquida, por lo que se ajusta tratamiento a Ampicilina / sulbactam + Metronidazol empírico. Se solicita PCR CD (+)

Se aísla *Serratia marcescens* en líquido pleural resistente a ampicilina, sensible a Tazonam por lo que se ajusta terapia.

Evoluciona en regulares condiciones generales, con compromiso de conciencia. Se realiza TAC de cerebro de control que impresiona sin lesiones agudas. Con mal control glicémico, entre 139 y 255, en seguimiento por diabetes por antecedente de DM1, hace ajuste de alimentación y terapia.

Se hospitaliza en UTIM para continuar manejo

EXAMEN FÍSICO DE INGRESO

Vigil, OTE, atento, no coopera

Bien hidratado y perfundido, mucosas pálidas, llene cap < 2 seg

Yugulares planas

Cardio RR2T no ausculto soplo, Pulmón MP (+) a izq, abolido a derecha. tubo pleural in situ sin sg de infección

Abdomen BDI, sin sg de irritación peritoneal, RHA (+).

EEII sin edema, sin signos de TVP.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO:

1. Insuficiencia respiratoria aguda en resolución
2. Empiema pleural derecho
 - Cultivo (+) *Serratia marcescens*
 - Drenaje pleural instalado 04/05
3. Sd diarreico por *clostridium Difficile*
4. Hiponatremia leve
5. Anemia severa (Tx 2U GR 02/05)
6. Antecedentes: DM1, ERC 2río a nefropatía diabética (última diálisis 01/05 CVC tunelizado subclavio izq), hipotiroidismo

EVOLUCIÓN DURANTE SU HOSPITALIZACIÓN:

HDN: Estable, tendiente a la hipotensión, el 03/06 presentó con episodio de lipotimia post diálisis que se interpretó como hipotensión ortostática. EKG sin signos de isquemia, se titulan VDO.

Sin nuevo gatillo transfusional, al alta Hb 7.5.

Cardiológico: Paciente con Ecocardiograma nov-2022 que muestra FEVI 30%. Evaluado por cardiología en contexto de estudio pre trasplante, quienes indican necesidad de estudio coronario, según hallazgos se debe discutir en equipo conducta a tomar (CRM vs angioplastia vs tto médico). Se deja interconsulta al alta a hemodinamia para agendar coronariografía.

Ventilatorio: logra suspender requerimientos O2 precozmente el 06/05. Estuvo con drenaje pleural por empiema, retirado ayer 05/06, control radiográfico del 06/06

Infeccioso:

- Empiema: Ingresa por insuficiencia respiratoria, del estudio, TC tórax informa derrame pleural bilateral, severo a derecha y leve a izquierda, con atelectasia prácticamente completa del pulmón derecho. Toracocentesis 03/05 compatible con exudado, cultivo (+) *Serratia marcescens* R a amp/sulb y cefazolina. Del manejo:

- Se instaló pleurostomía aspirativa. Se habría planteado posibilidad de resolución quirúrgica y decorticación, inicialmente no se realizó por alteración de pruebas de coagulación, posteriormente se desestima por buena evolución. Débitos por pleurostomía con tendencia a la baja. Evaluado por cirugía de tórax ayer, se retira tubo pleural, control radiográfico del 06/06

Fecha Epicrisis : 06/06/2023 17:57

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 06-06-2023 17:57:32

Página 3 de 4

- Desde el 08/05 en tratamiento con Ciprofloxacino EV. Evoluciona con mejoría de empiema, afebril, parámetros inflamatorios a la baja. Completa 37 días de tratamiento antibiótico.
Dada buena evolución, se decide alta hospitalaria.

- Digestivo: Ingresó con diarrea aguda, toxina y GDH (+), completa tratamiento con Vancomicina oral 14/14 días. Posteriormente se mantuvo con Vancomicina VO profiláctica mientras estuvo recibiendo terapia ATB (Ciprofloxacino). Posteriormente nuevamente con deposiciones líquidas, se repite toxina CD (-). Se amplía estudio con anti-endomisio (normal), coprocultivo (-).

Medio interno: ERC en HD, oligúrico. Mantiene HD trisemanal, última HD hoy 06/06, sin conflicto. Continuar hemodialisis en su centro. Se sugiere titular BH de programación de diálisis, ya que familiar refiere episodios de lipotimia frecuentes post diálisis.

Hematológico: Ingresó con anemia severa normo-normo, Tx 2 UGR. Hb de control al alza, sin exteriorización de sangrado. Anemia microcítica hipocrómica, perfil ferroprivo.
Además, trombocitopenia se ha profundizó durante hospitalización, actualmente en recuperación, al alta 142.000. Hemograma sin muestras de hemólisis. Última Tx 29/05 (1 U GR), se ha mantenido estable desde entonces.
Además, destaca TTPA elevado, intermitente, se solicita IC a Hematología, sugieren completar estudio: anticoagulante lúpico (-), FVIII 210%, FIX 57%, TTPA pre mezcla normal, con controles posteriores normales, fibrinógeno normal. Se interpreta como secundario a heparina intradiálisis, sin contraindicación quirúrgica.

Endocrino: Bradipsíquico, se controla TSH en 39 por lo que se titula dosis 09/05. Se recupera antecedente de mala adherencia a tratamiento. Control en 6-8 semanas.

Metabólico: DM1 en seguimiento por especialidad, en ajuste de esquema, se indica esquema al alta. Continuar controles con equipo de diabetes en CDT.

Nutricional: Paciente severamente desnutrido, sarcopénico, prealbúmina 4 al ingreso. Se mantuvo con progresión calórica.

DIAGNÓSTICOS DE ALTA:

- Insuficiencia respiratoria aguda parcial - resuelta
- Empiema derecho por Serratia en organización: Pleurostomía 04/05 - 06/06
- Primer episodio de diarrea por Clostridium difficile, tratado
- Hipotiroidismo descompensado en tratamiento
- Bicitopenia : Trombocitopenia - Anemia severa TTPA elevado en estudio
- Antecedentes: DM I, IC FE reducida, ERC Etapa V en diálisis

Diagnóstico de Egreso

DERRAME PLEURAL NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE - Empiema derecho por Serratia en organización: Pleurostomía 04/05 - 06/06
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO - Primer episodio de diarrea por CD tratado

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

En buenas condiciones generales, estable, afebril, sin requerimientos de O2.
última hemodialisis 06/06/23, bien tolerada

Plan Post Alta

Reposo relativo
Régimen de 2000 calorías al día: 4 comidas de 60 gramos CHO (Desayuno, almuerzo, once y cena), sin colaciones, sin sacarosa ni productos con fructosa
Tomar HGT 15 min antes de las comidas

Furosemida 40 mg c/12 hrs. Vía oral
Paracetamol 1 gramo. SOS, máximo cada 8 horas. Vía oral
Pregabalina 75 mg/noche Vía oral
Levotiroxina 200 mcg al día (tomar en ayunas) Vía oral
Clonazepam 0.5 mg/noche.Vía oral

Fecha Epicrisis : 06/06/2023 17:57

Página 3 de 4

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 06-06-2023 17:57:32

Página 4 de 4

Atenolol 12.5 mg/día. Vía oral

Lágrimas artificiales, 1 gota en cada ojo c/3 hrs

Insulina según el siguiente esquema:

- Tomar HGT (hemoglucotest) 15 minutos antes de las comidas

- Insulina Tresiba 2 unidades a las 18:00 hrs, vía subcutánea

- Insulina Novorapid 15 minutos antes de las comidas (desayuno, almuerzo, once y cena) según el siguiente esquema:

Menor a 80: nada

80-100: 0.5

100-180: 2.5

181-260: 3

261-340: 3.5

más de 340: 4

Controles al alta:

- Coronariografía: tiene hora agendada para el martes 27 de junio de 2023 a las 08:00 hrs en Hemodinamia (4to piso block central), debe ir en ayuno de 6 horas. Se entrega documento explicativo con indicaciones, debe traer consentimiento firmado (dado que estará en ayuno, se adjunta esquema de insulina PARA ESE DÍA)

- Diabetes: Solicitar hora de control en CDT diabetes con Enfermera o Nutri, control médico para agosto o septiembre.

- Nefrología: continuar sus controles en CENEFRO. Pedir hora al alta

- Endocrino: continuar sus controles con especialidad para control de hipotiroidismo. Durante su hospitalización, se controla TSH en 39 por lo que se titula dosis 09/05. Se recupera antecedente de mala adherencia a tratamiento. Control en 6-8 semanas. Pedir hora en CDT con interconsulta y esta epicrisis.

- Cirugía de tórax: control en 2 semanas a partir de hoy 06/06, con Dr. Villarroel en CDT (sobrecupo autorizado). Pedir hora con esta interconsulta.

- Continuar sus dialisis en su centro habitual.

Consultar en servicio de urgencias en caso de fiebre, dificultad respiratoria, dolor torácico o cuando estime necesario

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Régimen De 2000 Calorias Al Dia: 4 Comidas De 60 Gramos Cho (Desayuno, Almuerzo, Once Y Cena), Sin Colaciones, Sin Sacarosa Ni Productos Con Fructosa

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Camila Sepulveda Cabrera
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 06/06/2023 17:57

Página 4 de 4

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 13:13

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar